衛生局蘇局長世斌：

這個計畫累積幾年下來，目前已經有 8 萬多人接受這個服務，我相信需求也會慢慢地遞減，因為很多人裝過了，我們就可以有這個機會調整。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我真的誠心跟臺南市政府建議，不要再玩這種表面功夫，我們已經用 3 千人次做為基準，做了多少年了？這個需求會多，不會少，今年到現在做了多少件？申請完的是 8 百多件，申請的是 1,700 多件，雖然還沒有到年底。今天要求從 4 萬提高到 4 萬 4，你們說好，但是預算沒有改變，之前我們講的是，請臺南市政府增加預算，在維持基數 3 千人次不變的狀況之下，讓臺南市的長者得到照顧，這也不是為了原住民，原住民申請這個案子的只有多少而已，都是個位數。之前就講過了，跟原住民無關，你們面對臺南市老年的照顧是這樣做的，玩這種數字遊戲。

主席：(蔡議員宗豪)

接下來請尤榮智議員發言。

尤議員榮智：

感謝主席，局長，因為時間的關係，剛剛沒說完，如果是重症跟確診者在家中，衛生局要怎麼去消毒？

衛生局蘇局長世斌：

我們會先派人去家中巡視，檢查一下有沒有陽性的容器，就是孳生源，有的話我們就清理了，清理後就沒有問題，這個病人，如果是臥牀失能，我們會評估，如果他的居住的環境是完善的。

尤議員榮智：

如果是重病的，還要在家中請看護。

衛生局蘇局長世斌：

房間我們可以先關起來，如果有空調，我們就關起來，其他的房間先噴。

尤議員榮智：

但是噴的煙非常大。

衛生局蘇局長世斌：

沒有，如果他住的房間，能獨立的話，我們就不噴，除非真的沒辦法。

尤議員榮智：

你消毒時會影響到旁邊的東西，會不會影響到我們要吃的東西及環境衛生嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這些都有事先提醒先收起來，為了安全。

尤議員榮智：

如果拒絕噴藥，我們要怎麼解決？

衛生局蘇局長世斌：

拒絕的話，我們會再三勸導。

尤議員榮智：

勸導後他如果還是不要呢？

衛生局蘇局長世斌：

勸導真的不行的話……

尤議員榮智：

就會執行公權力？

衛生局蘇局長世斌：

對，會處罰，因為這是大家的事情。

尤議員榮智：

對，因為媒體報導，大家怨聲四起，有時候噴藥時。長者或家庭的東西，或是用餐的東西、家具都噴到，有的還要洗，這些非常麻煩。

衛生局蘇局長世斌：

一定要洗，要包起來、收起來。

尤議員榮智：

要注意並封存起來。

衛生局蘇局長世斌：

是。

尤議員榮智：

你要注意一下。

衛生局蘇局長世斌：

謝謝。

尤議員榮智：

針對流感疫苗，我們現在有 4 家，分別是國光、賽諾菲、東洋跟高端。國光的是 51%、賽諾菲 28%、東洋 12%、高端的 9%，總共 52 萬劑。大家都有選擇權，剛才有議員在問，要注射哪一種，我們可以自行選擇嗎？國中小也可以嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這個是公費疫苗，都是中央經費提供的。

尤議員榮智：

這是衛福部給我們的吧？

衛生局蘇局長世斌：

他照這個比例給我們。

尤議員榮智：

依照多少比例分配給臺南市吧？

衛生局蘇局長世斌：

分配給我們的量，就是照比例分配，都一樣。

尤議員榮智：

我們送到學校施打的，也是 4 種都送去嗎？

衛生局蘇局長世斌：

沒有啦，因為學校從國中小到高中，總共有 18 萬人，我們送到學校的要管理，因為我們還要登錄健保卡，所以疫苗我們會用最大宗的，基本上，我們就是用 26%那個最多的。

尤議員榮智：

要送到國中小的，你也要依照比例送到那邊讓學生施打，給大家選擇。

衛生局蘇局長世斌：

沒有，沒有依照比例，這樣沒辦法管理。

尤議員榮智：

不然國中小都施打什麼？

衛生局蘇局長世斌：

我們現在最多的都是施打國光，因為國光有 26 萬劑，才有辦法符合學校的需求。

尤議員榮智：

整間學校都施打，一定要施打比較多的那種。

衛生局蘇局長世斌：

都施打一樣的。

尤議員榮智：

我聽說如果到衛生所施打的，如果可以選擇的話，也不一定要施打某一種品牌對吧？你就自己選擇，看要施打哪一個品牌。

衛生局蘇局長世斌：

你如果跟他說想要施打哪一個品牌，你自己可以選擇。

尤議員榮智：

你如果要選擇的話，他就開一個證明。

衛生局蘇局長世斌：

要等。

尤議員榮智：

要開證明的話就要等通知，

衛生局蘇局長世斌：

如果不願意等也有自費的可以施打。

尤議員榮智：

這個實在很重要，這個東西要便民，A 型流感的症狀，我聽到醫生跟報紙報導，三種病會一起併發，非常嚴重，往生的案例，差不多都是比較年長，或是說本身有症狀的。

衛生局蘇局長世斌：

共病，就是有潛在疾病的。

尤議員榮智：

對，他無法承受細菌進到體內，抗體不夠生命就消殞了。

衛生局蘇局長世斌：

所以要打預防針。

尤議員榮智：

這種跟長者還有小孩相關的東西，小孩還有抗體，那種年長躺在床上的，一點抗體這都沒有了。

衛生局蘇局長世斌：

抵抗力比較差，一定要施打，我們鼓勵施打。

尤議員榮智：

但以前的COVID-19不也是一樣，剛才蔡淑惠議員說過，她兩位同學施打後，都往生了。

衛生局蘇局長世斌：

這是個案。

尤議員榮智：

死那麼多人還是個案嗎？

衛生局蘇局長世斌：

我們要看全國的數字。

尤議員榮智：

所以這個疫苗很重要，如何讓全國人民可以有一個好疫苗可以施打，這個比較重要。當然衛生局是關注整個臺南市，衛生局長今天就是維護百姓安全的領銜者，我們應該加強保護人民的身體，這個比較重要。不能說施打後，就出現病變，如果出現病變，誰敢施打呢？到最後都沒有人敢施打，加強。

衛生局蘇局長世斌：

我們會依照中央。

主席：(蔡議員宗豪)

接下來請陳昆和議員發言。

陳議員昆和：

感謝主席，蘇局長，目前登革熱在臺南市控制的情形如何？

衛生局蘇局長世斌：

差不多1萬5千例，15,095。

陳議員昆和

跟前次比起來有穩定下來了嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這是一年、一年看的，比如過去3年武漢肺炎期間，因為關閉國門，所以過去3年的案例幾乎非常少，但因為今年開放了，一些案例就進來了，傳染病進到社區後，因為大家比較沒有抵抗力，就會容易傳染。主要也是病媒蚊的因素，埃及斑蚊喜歡在城鎮化的地方，所以都市發展過程中，如果我們人口居住越來越密集的話，斑蚊的密度也會增加，再加上全球暖化等因素的影響。因為我們今年一開始就執行強力的篩檢，所以我們一開始就把所有的案例篩檢出來，篩檢後我們才能防治。這是因為科技的進步，我們有很方便的快篩試劑，這是今年不一樣的地方。

陳議員昆和

你有掌握現在曾文溪以北的病例有多少嗎？

衛生局蘇局長世斌：

曾文溪以北的病例都是零星案例，因為臺南是一個一日生活圈，曾文溪以北很多人都來市區上班。

陳議員昆和

在溪北被叮咬而確診的案例有多少？

衛生局蘇局長世斌：

目前溪北還沒有發現有社區群聚案。

陳議員昆和

依然還是在溪南這邊發生，回去溪北發病的？

衛生局蘇局長世斌：

對，大部分都是這樣來來去去，我們也有一些案例是去其他的縣市，比如中北部的縣市，感染後回來，我們都有遇到。

陳議員昆和

所以溪北目前沒有？

衛生局蘇局長世斌：

沒有社區群聚，就是零星案例。

陳議員昆和

我想這個非常重要。

衛生局蘇局長世斌：

但是我們要守好，不要讓它變成社區群聚。

陳議員昆和

其實你剛才說到重點，人口密集的地方有病媒蚊，所以一個都市的發展要正常。臺南市現在是把臺南市民趕向溪南府城這邊居住，溪北跟山區都被放著，整個臺南市的發展13年來是相當畸形的。

衛生局蘇局長世斌：

所以城市發展要均衡。

陳議員昆和

對，要注意均衡，臺南市升格為直轄市的13年來，這是最大的敗筆所在。局長，前陣子無蛋、毒蛋的事情，怎麼沒聽衛生局說，在臺南市有什麼問題嗎？

衛生局蘇局長世斌：

跟議座報告，關於進口蛋，臺南沒有，但是我們有接受中央委託做洗選或是液蛋加工，加工之後，我們就送回新北市，由中央統一處理。

陳議員昆和

所以確定臺南市你所管轄的轄區中，沒有這種蛋流入？

衛生局蘇局長世斌：

我們有稽查，如果要詳細的稽查紀錄，可以請科長補充。

陳議員昆和

我想瞭解一下，想說臺南市怎麼都沒有消息，全國這麼嚴重，屏東、高雄，結果臺南市沒有問題，是不是能夠瞭解一下？沒問題就對了吧？

衛生局蘇局長世斌：

請科長補充。

食品藥物管理科費科長偉鈴：

跟議座報告，臺南市並沒有儲存逾期蛋品的冷鏈倉儲，那些倉儲沒有在臺南市。針對農業部函文給我們的，有4家委託的洗選蛋廠跟液蛋廠，這4家洗選蛋廠跟液蛋廠，我們9月19號已經連續密集地稽查過了，現場都沒有看到巴西蛋，我們也有清查當時委

託生產的標示，都有如實標示產地是巴西，這些都是委託的，之後都回到畜產會，他們那邊再去做後續處理。

陳議員昆和

局長，我們校園毒品的問題有沒有改善？

衛生局蘇局長世斌：

這是一個很嚴重的問題。

主席：(尤議員榮智)

局長請回答。

陳議員昆和

我們會持續跟警察局還有教育局做預防跟宣導，我們會把數據提供給議座參考。

主席：(尤議員榮智)

謝謝陳昆和議員，接著請蔡宗豪議員發言，蔡議員發言後休息 10 分鐘。

蔡議員宗豪：

謝謝主席，請教一下衛生局長，最近衛生局忙於登革熱疫情，登革熱源頭的問題，就是一直擴散，導致現在勢不可擋，我這樣的說法有錯嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這是一個傳染病的過程。

蔡議員宗豪：

對，如果剛開始可以趕快找到源頭，可以儘速解決是最好的，對不對？

衛生局蘇局長世斌：

源頭除了病毒以外，還有病媒蚊，這個病媒蚊一直在社區。

蔡議員宗豪：

孳生源一直不斷增加。

衛生局蘇局長世斌：

病媒蚊在臺南市區其實都一直蠢蠢欲動。

蔡議員宗豪：

因為我在業務報告裡面看不到，現在全臺又有一個新的、即將到來的一個疫情，局長你有看到最近的新聞嗎？北部很多小孩子最近感染到的。

衛生局蘇局長世斌：

你講的是 RSV 或是腸病毒？

蔡議員宗豪：

沒有錯，RSV，因為看到全臺很多 RSV 的新聞，包括醫院檢驗出 6 種病毒，很多種對不對？其實症狀很多都相似，都會發燒，有流感，然後有登革熱，這麼多不同的狀況。局長，為什麼在業務報告裡面一頁都沒看到關於 RSV 的內容？

衛生局蘇局長世斌：

這個 RSV（呼吸道合體病毒），它是一個陳年的問題，在幼兒身上比較容易發生，這不是一個通報傳染病，重症之後才會通報。

蔡議員宗豪：

我知道，但像我今天遇到幾位醫生，他們也跟我說北部現在 RSV 的狀況。

衛生局蘇局長世斌：

在小兒科是很麻煩的。

蔡議員宗豪：

對，很嚴重，其實不只剛剛局長講的幼兒，還有國、高中生，我相信你也看到這個新聞吧？

衛生局蘇局長世斌：

有。

蔡議員宗豪：

國、高中生的傳染。

衛生局蘇局長世斌：

國、高中生的問題比較不大，幼兒的話，因為是一個呼吸道的感染，所以很嚴重。

蔡議員宗豪：

對，是說對人體的。

衛生局蘇局長世斌：

對小孩子。

蔡議員宗豪：

對，但我是說感染的話，如果又在校園引起這樣的狀況，像現在的流感在校園有幾成的感染數，局長有掌握嗎？

衛生局蘇局長世斌：

因為流感不是通報的傳染病，流感重症才會通報。

蔡議員宗豪：

對，我問的是重症。

衛生局蘇局長世斌：

臺南今年的重症，大概通報 90 幾例，重症確診 73 例，可能要住加護病房，流感死亡的話現在是 24 例。

蔡議員宗豪：

輕症的比較多。

衛生局蘇局長世斌：

輕症不會通報。

蔡議員宗豪：

我知道，就是輕症的比較多，所以針對這麼多狀況，流感、RSV，然後又有登革熱，一波接著一波，一波還沒處理好，一波又起。

衛生局蘇局長世斌：

這個叫做免疫負債，在 COVID-19 的 3 年期間，大家封閉國門、戴口罩勤洗手，所以大家都非常注意個人的公共衛生，因此很多的傳染病，尤其是呼吸道傳染病跟接觸傳染病幾乎都被控制了。現在又看到這樣的一個情況，所以我們要特別呼籲跟宣導。

蔡議員宗豪：

沒有看到你們特別提出來，沒有看到宣導。

衛生局蘇局長世斌：

我們會特別宣導，就是要戴口罩、勤洗手。

蔡議員宗豪：

前面沒有看到。

衛生局蘇局長世斌：

我們的新聞稿都有特別提到這個，但是針對 RSV，我們還沒有特別提到。

蔡議員宗豪：

因為新聞都報成這樣，臺南市還是沒有動作，登革熱都已經好幾個月，最近也在施打流感疫苗，COVID-19 最近還是有一些疫情，接下來的 RSV……

衛生局蘇局長世斌：

這些都是長期的問題，要長期宣導，這是長期的工作。

蔡議員宗豪：

我知道，還是要多做，如果本席今天把它提出來，RSV 就像剛剛局長講的，去年也有、前年也有，每一年都有，可是當全部的東西都跳出來時，臺南市負荷得了嗎？

衛生局蘇局長世斌：

這個是全國的問題。

蔡議員宗豪：

對，但是全國登革熱最嚴重的縣市在哪裡？

衛生局蘇局長世斌：

因為埃及斑蚊。

蔡議員宗豪：

在哪裡？在臺南市。

衛生局蘇局長世斌：

因為埃及斑蚊在臺南，所以這是臺南市最大的一個挑戰，也是我們要去面對的。

蔡議員宗豪：

這麼困難的挑戰，局長你很專業，怎麼沒有看到針對 RSV 等這些新的一些狀況的報告。

衛生局蘇局長世斌：

我們會針對所有的傳染病，發佈相關的警訊跟提醒，我們的團隊也都很敬業，謝謝議員的提醒跟指教，我們會特別針對這些。

蔡議員宗豪：

什麼時候開始做？

衛生局蘇局長世斌：

這個長期都有在做，其實新聞局的新聞稿都有，謝謝。

蔡議員宗豪：

好，因為看到每天的數字都很多，我也不希望在校園引起另外一波的感染熱潮。

主席：(尤議員榮智)

現在休息十分鐘。

《休息十分鐘》

主席：（尤議員榮智）

請各位同仁回到自己的位子，現在開始開會，請沈震東議員發言。

沈議員震東：

謝謝主席，衛生局蘇局長，我先問第一個問題，6 月登革熱疫情開始爆發之後，我想問衛生局在噴藥方面有沒有落拍，或者是市長指示之後，疫情評估狀況還好 所以目前先暫緩了？

衛生局蘇局長世斌：

我們的政策會隨著時間跟疫情調整，比如針對確診個案，24 小時內衛生所的人，會到家裡去做壓罐跟噴藥。

沈議員震東：

本席有聽到直播時你對其他議員的回應，我想問有沒有這樣的一個情況？有沒有錯估形勢或錯估政策的推動，所以才導致這樣的疫情爆發？有或沒有？

衛生局蘇局長世斌：

我們完全按照 SOP 處理疫情。

沈議員震東：

所以你的意思是沒有？

衛生局蘇局長世斌：

單一個案、群聚個案該怎麼處理，我們就這樣做。

沈議員震東：

好， 謝謝局長，請社會局照管中心陳儷今主任，我想請問一個問題，針對臺南市北區長照創新整合服務中心，上一次的會期，通過了墊付款案，之後就完全沒有消息，可不可以告訴我們現在的進度？

長期照顧管理中心陳主任儷今：

跟議座報告，有關北區地方創生長照創新整合型的服務據點，目前土地的話，我們在 110 年 2 月 6 日已經跟國有財產署簽署取得共同改良利用。相關進度的話，我們的規劃設計在 7 月 25 日已經決標，目前在做細部設計中。

沈議員震東：

主任，我要提醒一下社會局，我們非常引頸期盼長照創新整合服務中心，但是又很怕受傷害。 除了這個會期外，我在很多會期都提過，也再次強調，小東公宅有一個社會福利的長照服務機構，接下來聖安社區活動中心的二樓也會做據點，再來開元路上的開元市場上面，也有悠然家園。開元路元寶里活動中心勝安這邊被你們收回去後，也在做長照的協助服務，鄭子寮重劃區這邊的話，明德國中旁邊也有，再來華德這邊也有，針對未來的經營狀況，會不會有供過於求或供不應求的狀況，有沒有做過評估？

長期照顧管理中心陳主任儷今：

我們的長照相關布點包括日照，北區創生爾後會有一個小規機，它可以收 120 個對，另外還有有關失智的團體家屋。

沈議員震東：

有別於以往的服務對不對？

長期照顧管理中心陳主任儷今：

對。

沈議員震東：

我知道你要表達的意思，因為我們非常瞭解這個政策的脈絡，我想再問一個問題，在這樣的一個坪數之下，剛才跟主任請教過，六甲這邊其實蠻多人詢問，意願蠻高的，在這樣一個狀況之下，未來跟鐵道局共同經營，以我們對於鐵道局的認知，賺的話我們要一起分，但是賠的話，不好意思，社會局自己處理，社會局有沒有心理準備？未來要OT，營運上會不會有一些問題或狀況？要不要先超前部署，去了解市場需求，有沒有人會來經營？未來的經營模式，至少社會局不要挹注太多經費，就可以達到持平的狀況。

長期照顧管理中心陳主任儷今：

目前公有建築物，倘若有長照服務的使用。我們大部分是採場地出租的作法，相關的硬體建築，原則上會由廠商做相關的處理，有關廠商的選擇，我們採遴選相關的機制。

沈議員震東：

我們再次強調，這個要超前部署，去瞭解到底有沒有這樣的市場需求、市場機制，甚至營運單位都要先提早先瞭解，否則到時蓋完，又苦於沒人標，如果有人標很好，但是未來沒人來營運。這樣都是空轉，提醒照管中心主任。

長期照顧管理中心陳主任儷今：

好，謝謝議座。

沈議員震東：

再請教人團科黃科長，臺灣目前現在的狀況，就是以老扶老、以老養老，您在照管中心其實也時任多年，未來有沒有要推動時間銀行？因為很多鄉親其實認為，我還有能力去照顧別人時，我用自己的時間，去換我未來有的時間，日後可以被照顧。沒關係，我下段時間再問。

主席：（尤議員榮智）

接下來請李偉智委員發言。

李委員偉智：

謝謝，我就教衛生局蘇局長，其實你的工作業務也很辛苦，你跟團隊都非常認真，但是有些問題，我還是要講一下。上週我們通過電話，我一直強調新化分院的問題，就算它是衛福部經營的，針對未來的醫療管理，當然醫事科每年也都會對它評鑑，它的分數到底好或不好？

衛生局蘇局長世斌：

評鑑基本上門檻很低，只要達到設置標準的話都會過。

李委員偉智：

應付基本的需求、醫療法規的需要而已，實際到底它的營業，不要說營業，它是不是符合我們在地需求的醫療，這方面我們沒有進一步的督導機會。

衛生局蘇局長世斌：

目前我們還沒有找到很有效的著力點，因為它是衛福部的部立醫院，這是中央的。

李委員偉智：

局長，人命關天，南科其實未來在安定交流道下，也即將要建立新的一個地區醫院